Saving Normal: 정상성 구별 및 애도의 보존

알렌 프랜시스(Allen Frances)의 정신의학 비판과 애도의 병리화 반대 논증 요약

---

1. 진단의 인플레이션(Diagnostic Inflation)과 정신의학의 과잉 확장

본 서는 현대 정신의학이 인간의 보편적 경험을 질병의 영역으로 편입시키는 현상을 비판함. 알렌 프랜시스는 DSM-5의 개정이 '정상'의 영토를 축소시키고, 대중을 불필요한 약물 치료와 진단명 아래 종속시키고 있다고 주장함.

- **의료화의 가속:** 일시적인 기분 변화, 사소한 주의력 부족, 노화에 따른 건망증 등을 장애로 규정하여 환자군을 인위적으로 확대함.
- **제약 산업의 영향:** 경제적 이익을 목적으로 질병을 마케팅하는 '질병 판매(Disease Mongering)' 현상이 만연함.
- **회복 탄력성의 간과:** 인간의 자연적 치유 기제와 환경 적응 능력을 무시하고 모든 고통을 의학적 개입의 대상으로 간주함.

2. 애도(Grief)와 주요 우울 장애(MDD)의 차별적 양상

프랜시스는 애도가 사별에 대한 지극히 정상적이고 적응적인 반응임을 강조하며, 이를 병리적 우울증과 명확히 구분함.

구분 항목	정상적 애도 (Normal Grief)	주요 우울 장애 (MDD)
발생 원인	사별이라는 명확하고 객관적인 외부 사건에 기인함.	외부 사건과 무관하거나 원인에 비해 과도한 증상이 나타남.
정서적 질감	고통이 파도처럼 밀려왔다 물러가는 양상을 보임(Pangs of grief).	불쾌하고 고통스러운 기분이 하루 종일 지속되며 호전되지 않음.

구분 항목	정상적 애도 (Normal Grief)	주요 우울 장애 (MDD)
자아 존중감	상실로 인한 공허함을 느끼나, 전반적인 자아 가치감은 유지됨.	심한 자기비난, 무가치감, 병적인 죄책감이 핵심 증상으로 나타남.
시간적 경과	시간이 흐름에 따라 상실을 수용하며 점진적으로 완화됨.	치료 없이는 지속되거나 시간이 갈수록 악화되는 경향이 있음.
핵심 관심사	고인과의 추억과 상실의 의미에 집중함.	자신의 무능함, 미래에 대한 절망 등 자기 초점적 부정 사고에 매몰됨.

3. '사별 배제 규정' 삭제의 부당성 및 비판

DSM-5가 사별 후 2주 만에 우울증 진단을 가능하게 한 것은 정신의학적 오만이자 실책임. 프랜시스는 이에 대해 다음과 같은 논리적 근거로 반박함.

① 맥락적 타당성의 무시

우울 증상 자체보다 '왜 슬픈가'라는 맥락이 중요함. 사별 직후의 증상은 고인과의 애착 수준을 반영하는 정상적 지표이지 뇌의 고장이 아님.

② 실존적 고통의 의학화

애도는 인간이 사랑을 확인하고 삶의 의미를 재정립하는 필수적인 과정임. 이를 의학적으로 억제하는 것은 인간의 심리적 성숙 기회를 찬탈하는 것과 같음.

③ 자원의 비효율적 배분

정상적 범주의 슬픔에 의료 자원이 낭비되면서, 정작 긴급한 케어가 필요한 중증 정신질환자들이 방치되는 의료적 불평등이 심화됨.

4. 결론: 인간성 수호로서의 정신의학

정신의학의 본령은 삶의 필연적인 고통을 약물로 지우는 것이 아니라, 비정상적이고 파괴적인 질병으로부터 인간을 구제하는 데 있어야 함. 프랜시스는 애도할 권리를 보호하는 것이 곧 인간의 존엄성과 정상성을 지키는 보루임을 천명함.

본 요약본은 알렌 프랜시스의 『Saving Normal』 내용을 바탕으로 학술적 목적을 위해 정리됨.